

मूत्रमार्ग पुनर्निर्माण (Urethroplasty)

रोगी जानकारी · मूत्रमार्ग संकुचन को ठीक करने की सर्जरी

WARWIKI

Urethroplasty एक सर्जरी है जो मूत्रमार्ग (urethra) — वह नली जो पेशाब को शरीर से बाहर ले जाती है — के संकुचित, घाव वाले हिस्से को ठीक करती है। इस संकुचन (stricture) से पेशाब की धारा धीमी या रुकती है; यह सर्जरी उसे फिर से खोलती है और सबसे टिकाऊ समाधान है।

इस प्रक्रिया के बारे में

एक **stricture** मूत्रमार्ग में एक संकुचित, घाव वाली जगह है जो मूत्राशय खाली करना मुश्किल बनाती है। बार-बार खिंचाव या कटान के विपरीत, urethroplasty मूत्रमार्ग को **पुनर्निर्मित** करती है — सफलता दर **85-95%** है। विधि संकुचन की जगह और लंबाई पर निर्भर है:

- **चीरा** लिंग (penis) पर, अंडकोष और गुदा के बीच (perineum) में, या दोनों जगह हो सकता है।
- **छोटे** संकुचन को **निकालकर स्वस्थ सिरे जोड़** दिए जाते हैं।
- **लंबे** संकुचन को **ग्राफ्ट से चौड़ा** किया जाता है — अक्सर गाल के अंदर की झिल्ली का ग्राफ्ट (इस पर अलग handout है)।

आपके सर्जन आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन-सी विधि सही है।

क्या यह सुरक्षित है?

Urethroplasty एक स्थापित और अत्यंत प्रभावी सर्जरी है; अधिकतर पुरुषों का मूत्रमार्ग बाद में खुला रहता है। किसी भी सर्जरी की तरह कुछ जोखिम हैं — रक्तस्राव, संक्रमण, या समय के साथ संकुचन का लौटना (जो अक्सर दोबारा ठीक होता है)। स्तंभन (erection) या वीर्यपात पर प्रभाव असामान्य है और अक्सर अस्थायी होता है।

शब्दों को समझें

मूत्रमार्ग (Urethra)

वह नली जो पेशाब को शरीर से बाहर ले जाती है।

Stricture

मूत्रमार्ग में एक संकुचित, घाव वाली जगह जो पेशाब की धारा धीमी या रोकती है।

Urethroplasty

संकुचन को ठीक कर मूत्रमार्ग को सामान्य चौड़ाई में पुनर्निर्मित करने की सर्जरी।

Graft

आपके ही ऊतक का एक छोटा टुकड़ा (अक्सर गाल के अंदर से) जो मूत्रमार्ग चौड़ा करने में काम आता है।

Perineum

अंडकोष और गुदा के बीच का क्षेत्र, जहाँ अक्सर चीरा लगता है।

Catheter

एक मुलायम नली जो ठीक होने के दौरान लगभग 1-4 हफ्तों तक मूत्रमार्ग में रहती है।

Urethrogram

मूत्रमार्ग का X-ray; catheter निकालने से पहले यह जाँचता है कि सर्जरी ठीक से भरी है।

जनरल एनेस्थीसिया

वह दवा जो सर्जरी के दौरान आपको गहरी नींद में और दर्द-मुक्त रखती है।

क्या इसमें दर्द होगा? सर्जरी जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया में होती है, इसलिए उस दौरान कुछ महसूस नहीं होता। बाद में चीरे के आसपास (लिंग और/या perineum) कुछ हफ्तों तक दर्द, सूजन और नील रह सकते हैं — बर्फ, अंडकोष सहारा (scrotal support), और दर्द-निवारक दवाएँ मदद करती हैं। जागने पर catheter लगा होगा। सर्जरी का समय अक्सर 2-4 घंटे होता है।

तैयारी कैसे करें (सर्जरी से पहले)

- **जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया** में होती है — उपवास और दवाओं (blood thinners सहित) के बारे में सभी निर्देश मानें।
- **पेशाब की जाँच (urine test)** संक्रमण देखने के लिए होती है — संक्रमण पहले ठीक होना ज़रूरी है।
- **धूम्रपान न करें** — यह ठीक होने में देरी करता है। अगर गाल का graft लग सकता है, तो दंत सफाई की सलाह दी जा सकती है।
- बाद में **catheter (लगभग 1-4 हफ्ते)** की योजना बनाएँ और घर जाने के लिए किसी को साथ लाएँ।

अपनी टीम को पहले से बताएँ यदि आप:

- **blood thinner** लेते हैं, या पेशाब/त्वचा का संक्रमण है
- पहले मूत्रमार्ग की सर्जरी, radiation, या lichen sclerosus जैसी त्वचा की बीमारी हुई हो

सर्जरी के दौरान क्या होता है

- 1 आप एनेस्थीसिया से गहरी नींद में या कमर के नीचे सुन्न होते हैं; एंटीबायोटिक दिया जाता है।
- 2 सर्जन संकुचन के ऊपर चीरा लगाते हैं (लिंग, perineum, या दोनों) और घाव वाले हिस्से को खोलते हैं।
- 3 संकुचन को ठीक किया जाता है — निकालकर सिरे जोड़े जाते हैं, या graft से चौड़ा किया जाता है।
- 4 पेशाब निकालने और सर्जरी की सुरक्षा के लिए **catheter** डाला जाता है; चीरे बंद किए जाते हैं।

बाद में

- आप **catheter** के साथ घर जाते हैं, आमतौर पर **लगभग 1-4 हफ्तों** तक। आपकी टीम देखभाल सिखाएगी — इसे खींचें नहीं।
- catheter के आसपास सूजन, नील और हल्का **खून-मिला पेशाब** शुरू में सामान्य है।
- कई हफ्तों (अक्सर ~6) तक **भारी उठाना, जोर लगाना, साइकिल चलाना और यौन संबंध** से बचें।
- catheter निकालने से पहले आमतौर पर **मूत्रमार्ग का X-ray** होता है यह देखने के लिए कि ठीक हो गया है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- catheter **निकल जाए, बंद हो जाए, या पेशाब बंद कर दे**
- बुखार या ठंड लगना, या चीरे पर बढ़ती लालिमा, दर्द, या स्राव
- भारी रक्तस्राव, या catheter निकालने के बाद **पेशाब न हो**

याद रखने योग्य तीन बातें

1. Urethroplasty संकुचित मूत्रमार्ग को पुनर्निर्मित करती है और सबसे टिकाऊ समाधान है। चीरा लिंग, perineum, या दोनों पर हो सकता है; graft (अक्सर गाल से) भी लग सकता है — आपके सर्जन समझाएँगे।
2. तैयारी: उपवास और दवा के निर्देश मानें, पहले कोई भी संक्रमण ठीक करें, धूम्रपान न करें, और catheter (लगभग 1-4 हफ्ते) की योजना बनाएँ।
3. Catheter टीम के निकालने तक रखें (आमतौर पर X-ray के बाद); कई हफ्तों तक भारी काम और यौन संबंध से बचें। catheter बंद हो, बुखार हो, या catheter निकालने के बाद पेशाब न हो तो तुरंत बुलाएँ।